

통보 사항

1. 제 목 : 개인 미수금 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ★병원

3. 내 용

가. 업무개요

★병원은 국가유공자 및 지역주민에게 요양급여를 제공하고 「국민건강보험법」에 따라 진료비를 산정하고 진료비 중 일부인 본인부담금을 환자에게 수납하고 있으며 '20. ~ '21.10월까지 아래 [표 1]과 같이 26억 원 상당을 수납하였습니다.

[표 1] 진료비 본인부담금 수납 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년			2021년 1~9월			합 계
	입원	외래	계	입원	외래	계	
입 원	331,256	1,023,100	1,354,356	296,671	981,999	1,278,670	2,633,026

나. 관련법령 및 판단기준

「보훈병원 운영규정」 제32조(진료비 징수)에 따르면 입원환자의 진료비는 퇴원시 징수하는 것으로 원칙하되 필요시 병원장이 정하는 바에 따르며, 외래환자의 진료비는 매회 징수하는 것으로 정하고 있으며, 「회계규정」 제48조에는 장기미납금 처리에 대해 여러 차례 독촉장을 발부 등 필요한 조치를 취하도록 정하고 있습니다.

따라서, ★병원에서는 입원환자는 퇴원 시, 외래환자는 검사 및 처치행위 이전에 진료비를 매회 수납하여 미수금이 최대한 발생하지 않도록 관리하여야 하고 미수금 발생 시 독촉장 발부 등 회수 노력을 통해 병원 손실이 발생하지 않도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, '18. 9~'21.10. ★병원의 개인미수금 발생 현황을 확인한 결과, 퇴원의 경우 응급실 부재로 인한 야간원무과 미운영으로 '야간 및 휴일 퇴원환자 수납처리 방안'(@@@-719, '19. 2.28.)을 정하고 휴일 및 야간에 응급 또는 사망으로 퇴원 처리가 불가피한 경우 병동 간호사가 진료비 지불각서(가퇴원) 작성 및 수납 안내 등을 하고 가퇴원 처리한 후 심사완료된 진료비 납부요청을 하고 있으나 미납부로 미수금이 발생하고 있으며, 심사와 사전심사 이전에 환자의 요구에 의해 퇴원하는 경우 심사조정에 따라 진료비 증감을 고려하여 수납하여야 하나, 퇴원시점의 처방만 계산한 진료비를 수납하여 심사 이후 진료비 증가로 인해 퇴원 개인미수금이 발생하였고,

외래의 경우 진료과 과내 검사(치과 파노라마검사 등)를 수납하지 않고 선 시행한 후 귀가하거나, 진료비 수납 및 귀가 후 추가처방 입력 등으로 인해 미수납액이 발생되면 당일 EMR시스템의 수납대기 자료를 활용하여 환자에게 미수납액 발생 사항을 설명 후 미수금으로 등록하여 향후 내원 시 미수금이 회수될 수 있도록 관리하여야 함에도 최대 62일 이후 미수금을 등록하는 등 미수금 관리가 미흡한 것으로 확인됩니다.

또한, 발생한 미수금 회수를 위해 유선연락 및 문자발송을 하고 있다고 하나, 이에 대한 연락일자, 횟수 등 관리기록 없이 미수금현황만 관리하고 있으며, 감사기간 중 11건 800,880원 회수하고 아래 [표 2]와 같이 23건 1,167,900원의 미수금으로 관리하고 있는 것이 확인됩니다.

[표 2] 개인 미수금 발생 현황

(단위 : 원)

구분		합 계	2019년	2020년	2021년 9월
입원	건수	4	-	2	2
	금액	682,640	-	287,190	395,450
외래	건수	19	6	3	10
	금액	485,260	272,660	100,980	111,620
합계	건수	23	6	5	12
	금액	1,167,900	272,660	388,170	507,070

4. 관계기관의 의견 : ★병원에서는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ★병원장은

- 입원·외래 진료미수금 발생 프로세스를 재점검하여, 리스크 최소화 할 수 있도록 조치하고,
- 미수금 등록 및 미수금 관리대장을 작성하여 미수금을 철저히 관리하여 주시기 바랍니다.(통보)